



INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL		VIGILANCIA	
FORMATO REPORTE DE SOSPECHA DE EVENTOS ADVERSOS A MEDICAMENTOS - FOREAM			
Código: IVC-VIG-FM026	Versión: 01	Fecha de Emisión: 05/04/2016	Página 1 de 3

1. INFORMACIÓN DEL REPORTANTE				
Fecha de notificación	Origen del reporte		Nombre de la Institución donde ocurrió el evento	Código PNF
	Departamento – Municipio			
2023-05-18	CALDAS - MANIZALES		DOMICILIO	
Nombre del Reportante primario	Nombre del Paciente o Acudiente	Consecutivo	Profesión del reportante primario	
JHONATAN FERNANDO VARGAS LIZCANO	ACUDIENTE	ugoK0nwQ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	
Correo electrónico institucional del reportante primario				
jvargas@encontactopeoplemarketing.com				

2. INFORMACIÓN DEL PACIENTE						
Fecha de nacimiento del paciente	Edad del paciente en el momento del EA	Documento de identificación del paciente	Iniciales del paciente	Sexo	Peso	Talla
	Edad – Años/Meses/ días	CC TI RC NUIP Cód. Lab Otro S/I		M F S/I	(Kg)	(cm)
1964-10-20	58	C.C - 30292016	CLAM	F	74	168
Diagnóstico principal y otros diagnósticos:						
Acromegalia						
DIABETES TIPO 2						
HIPERTENSION ARTERIAL						
ANTIDEPRESIVO						



INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL		VIGILANCIA	
FORMATO REPORTE DE SOSPECHA DE EVENTOS ADVERSOS A MEDICAMENTOS - FOREAM			
Código: IVC-VIG-FM026	Versión: 01	Fecha de Emisión: 05/04/2016	Página 1 de 3

3. INFORMACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS								
Registre todos los medicamentos utilizados y marque con una “S” el (los) sospechoso(s), con una “C” el (los) concomitantes y con una “I” las interacciones.								
S/C/I	Medicamento (Denominación Común Internacional o Nombre genérico)	Indicación	Dosis	Unidad de medida	Vía de administración	Frecuencia de administración	Fecha de inicio	Fecha de finalización
S	LANREOTIDE(120)	ACROMEGALIA	120	MG	SUBCUTANEA PROFUNDA	2 UNIDADES CADA 28 DIAS	23/ABR/2020	CONTINUA
C	INSULINA DE GLUDEC	DIABETES TIPO 2	100	UNI/ML	SUBCUTANEA	1 APLICACIÓN 57 UNIDADES DIARIA	SIN INFORMACION	CONTINUA
C	AMLODIPINO	HIPERTENSION ARTERIAL	5	MG	ORAL	1 TABLETA DIARIA	SIN INFORMACION	CONTINUA
C	HIDROCLOROTIAZIDA	RETENCION DE LIQUIDOS	25	MG	ORAL	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	CONTINUA
C	PARACETAMOL	DOLOR	500	MG	ORAL	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	CONTINUA
C	FLUOXETINA	ANTIDEPRESIVO	20	MG	ORAL	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	CONTINUA
C	AZATIOPRINA	INMUNOPRESOR	50	MG	ORAL	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	CONTINUA
C	VALSARTAN	HIPERTENSION ARTERIAL	160	MG	ORAL	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	CONTINUA
C	EMPAGLIFLOZINA+METFORMINA	DIABETES TIPO 2	12,5/1000	MG	ORAL	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	CONTINUA
C	PIRIDOSTIGMINA	SIN INFORMACION	60	MG	ORAL	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	CONTINUA
Información comercial del medicamento sospechoso								
Titular del Registro sanitario			Nombre Comercial		Registro sanitario		Lote	
			SOMATULINE				SIN INFORMACION	



INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL		VIGILANCIA	
FORMATO REPORTE DE SOSPECHA DE EVENTOS ADVERSOS A MEDICAMENTOS - FOREAM			
Código: IVC-VIG-FM026	Versión: 01	Fecha de Emisión: 05/04/2016	Página 1 de 3

4. INFORMACIÓN DEL EVENTO ADVERSO	
Fecha de Inicio del Evento Adverso: 2023-05-10	Evento adverso: DOLOR DE CABEZA-MAREO-CAIDA DESDE SU PROPIA ALTURA-ESGUINCE
Descripción y análisis del Evento Adverso: ACUDIENTE REFIERE QUE LA PACIENTE PRESENTA DOLOR DE CABEZA, MAREO,ADICIONAL INDICA QUE EL DIA MIÉRCOLES 10/05/2023 LA PACIENTE PRESENTO CAIDA DESDE SU PROPIA ALTURA A CAUSA DEL MAREO Y LE PRODUJO UN ESGUINCE PERO NO INFORMA LITERALIDAD	Desenlace del evento (Marcar con una X) Recuperado / Resuelto sin secuelas Recuperado / Resuelto con secuelas Recuperando / Resolviendo X No recuperado / No resuelto Fatal Desconocido Seriedad (Marcar con X) Produjo o prolongó hospitalización Anomalía congénita Amenaza de vida Muerte (Fecha: _____) Produjo discapacidad o incapacidad permanente / condición médica importante X Ninguno

	Si	No	No sabe
¿El evento se presentó después de administrar el medicamento?	X		
¿Existen otros factores que puedan explicar el evento (medicamento, patologías, etc.)?	X		
¿El evento desapareció al disminuir o suspender el medicamento sospechoso?			X
¿El paciente ya había presentado la misma reacción al medicamento sospechoso?			X
¿Se puede ampliar la información del paciente relacionando con el evento?	X		